



اضطراب الشخصية الزورانية

Paranoid Personality Disorder

دورة تدريبية متخصصة للأخصائيين النفسيين والمعالجين السلوكيين

بنهاية هذه الدورة ستكون قادرًا على...

تُغطي هذه الدورة المتخصصة جميع الجوانب التشخيصية والعلاجية لاضطراب الشخصية الزورانية وفق أحدث المعايير الدولية.

01

التعريف والتشخيص

تعريف الاضطراب وتطبيق معايير DSM-5 و ICD-11 بدقة إكلينيكية.

02

آلية التفكير

فهم النموذج المعرفي والتشوهات الفكرية الكامنة لدى المصاب.

03

التشخيص التفريقي

التمييز بين الاضطراب والحالات المتشابهة إكلينيكيًا.

04

التدخل العلاجي

اختيار وتطبيق الأساليب العلاجية المناسبة داخل الجلسة.

05

إدارة العلاقة العلاجية

التعامل الفعّال مع المراجع وبناء التحالف العلاجي.



قصة افتتاحية

هل هو مجرد حذر... أم يعاني من اضطراب شخصية؟

"أحمد، 38 عامًا، يعمل مهندسًا. جاء إلى العيادة بسبب مشكلات في العمل. يرى أن زملاءه يتآمرون عليه، وأن مديره يسعى لإقالته دون سبب. رفض دعوة زملائه للغداء مرات عديدة خشية أنهم يريدون معرفة أسرارهم. زوجته تقول إنه 'لا يثق بأحد' منذ سنوات."



هل ما يعانيه أحمد هو حذر طبيعي ناتج عن تجارب سلبية، أم أننا أمام اضطراب شخصية حقيقي؟ كيف نميز؟

تعريف اضطراب الشخصية الزورانية

التعريف وفق DSM-5

نمط مستدام من عدم الثقة والشك المتفشي تجاه الآخرين، يبدأ في مرحلة البلوغ المبكر، ويظهر في سياقات متعددة. يفسّر المصاب دوافع الآخرين على أنها خبيثة أو مؤذية، حتى في غياب أي دليل كافٍ على ذلك.

الكلمات المفتاحية

- الشك المستمر وغير المبرر
- سوء تفسير النوايا
- الحساسية الزائدة للنقد
- الضغينة والانتقام

لماذا يُسمّى "اضطراب الشخصية الشكاكة"؟

يُستخدم مصطلح "الشكاكة" في الأدب العربي السريري للإشارة إلى الشك المزمن الذي يُشكّل نمط الشخصية بأكمله. الكلمة "Paranoid" تعني في أصلها اليوناني "التفكير خارج الحدود الطبيعية"، وهو ما يعكس عجز الشخص عن ثقة الآخرين بشكل واقعي.



يُميّز هذا الاضطراب عن الذهان البارانوي بغياب الأوهام الثابتة والاختبار الكافي للواقع في معظم الأوقات.

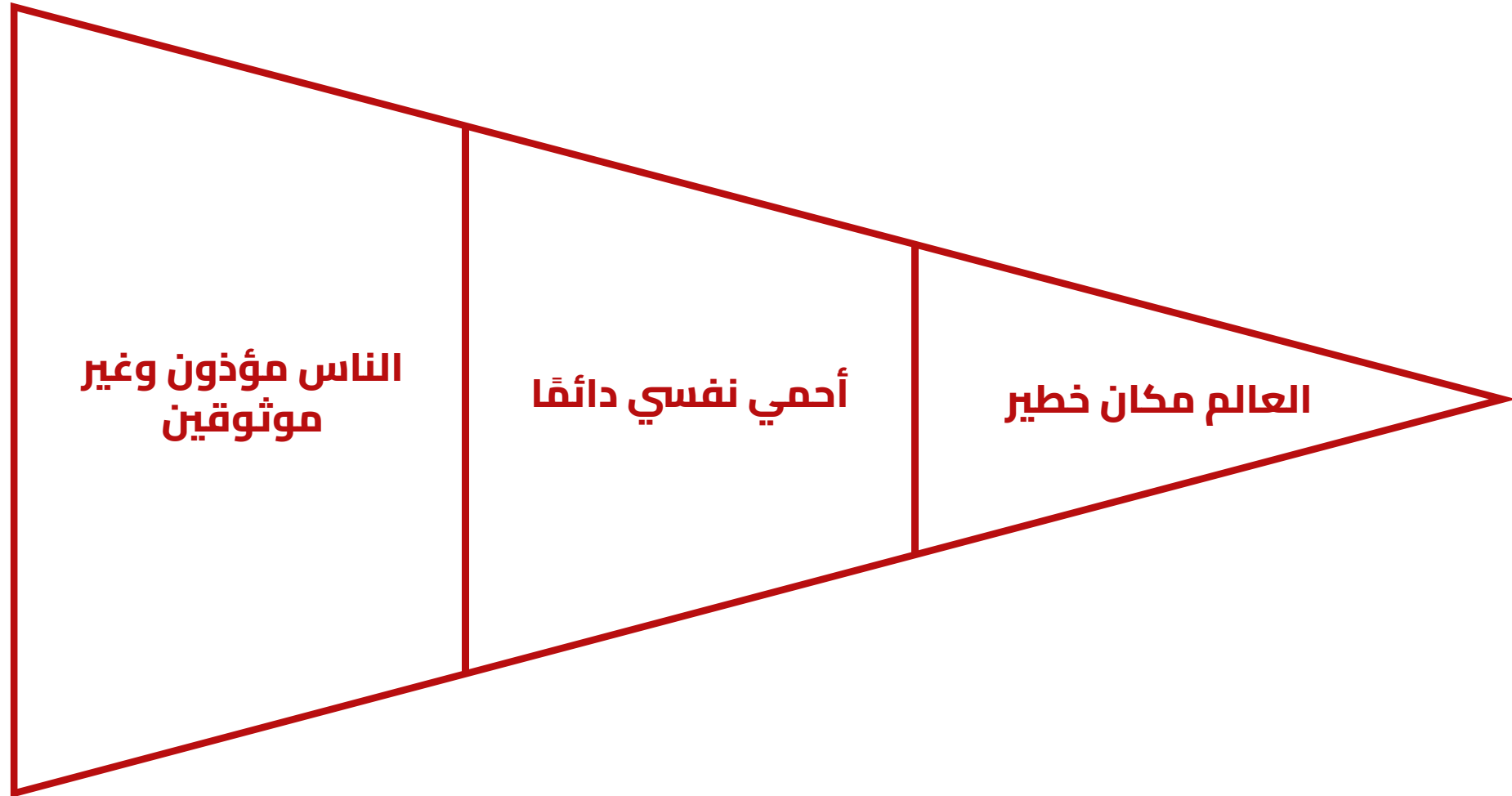
الفرق بين الحذر الطبيعي والشك المرضي

يُعدّ التمييز بين الحذر الصحي والشك الزوراني المرضي أحد أهم المهارات الإكلينيكية في تشخيص هذا الاضطراب.

المعيار	الحذر الطبيعي	الشك المرضي
المحفز	يستند إلى أدلة وتجارب حقيقية	يظهر بدون دليل أو بدليل ضئيل
المرونة	يتغير بتغير الظروف والمعلومات	مستمر وثابت بصرف النظر عن الأدلة
التأثير	لا يعيق الحياة اليومية	يُعيق العلاقات والعمل والحياة الاجتماعية
الاستبصار	الشخص يدرك طبيعة شكوكه	غياب الاستبصار، يراها حقائق مؤكدة
الانتشار	محدود بسياق معين	يشمل معظم العلاقات والمواقف
الاستجابة	يقبل التطمينات المنطقية	لا يقتنع بالتطمينات ويرفضها

كيف يرى الشخص الزوراني العالم؟

يعمل الشخص الزوراني وفق منظومة معرفية مغلقة تُشكّل تفسيره للواقع بالكامل، مما يولّد حالة دائمة من اليقظة والدفاعية.



هذه الدائرة المغلقة من التفكير تجعل كل موقف عادي يبدو تهديدًا محتملًا، وكل شخص متعاطف يبدو متآمرًا محتملًا — مما يعزز الاعتقادات الأصلية باستمرار ويجعل العلاج أكثر تعقيدًا.

مدى الانتشار وعوامل الخطورة

2:1

نسبة الذكور

يُشخّص لدى الذكور أكثر من الإناث في معظم الدراسات

2.3%

نسبة الانتشار

في عموم السكان وفق الدراسات الوبائية الحديثة (2.3-4.4%)

18-30

عمر البداية

تظهر السمات عادةً في مرحلة البلوغ المبكر

الهجرة والأقليات

معدلات أعلى في المجموعات المهمشة اجتماعيًا

صدمات مبكرة

الإساءة أو الإهمال أو التنمر في الطفولة

تاريخ عائلي

وجود فصام أو اضطرابات بارانوية في الأسرة

العزلة الاجتماعية

ضعف شبكات الدعم الاجتماعي يُعزز النمط الزوراني



معايير التشخيص وفق DSM-5

يتطلب التشخيص وجود أربعة معايير أو أكثر من المعايير السبعة التالية، مع استمرارها وظهورها في سياقات متعددة:

1	الشك غير المبرر يشك في أن الآخرين يستغلونه أو يؤذونه دون دليل كافٍ. مثال: يعتقد أن جاره يتجسس عليه.
2	الشك في الأصدقاء يشغله الشك في مصداقية الأصدقاء والمقربين. مثال: يتساءل لماذا يتصل صديقه، ويرى في ذلك خفية ما.
3	الإحجام عن البوح يمتنع عن مشاركة المعلومات خشية استخدامها ضده. مثال: يرفض إخبار طبيبه بتفاصيل شخصية.
4	قراءة التهديد يقرأ في التعليقات المحايدة معاني قهينة أو تهديدية. مثال: يفسر ابتسامة زميله سخرية منه.
5	الضعينة المستمرة لا يغفر الإهانات أو الإساءات المتصورة. مثال: يحمل حقداً لسنوات بسبب موقف عابر.
6	الحساسية للهجوم يشعر بأن شخصيته أو سمعته تُهاجم ويردّ بغضب. مثال: يستجيب لتغذية راجعة بسيطة بعداء حاد.
7	الشك في الشريك شكوك متكررة وبلا مبرر في إخلاص الزوج/الزوجة. مثال: يراقب هاتف شريكه باستمرار دون سبب.

متى نُشخّص؟ ومتى لا نُشخّص؟

شروط التشخيص الكاملة

- لا تظهر فقط في سياق الفصام أو اضطراب ثنائي القطب أو اضطراب ذهاني آخر
- لا تُعزى إلى التأثيرات الفسيولوجية لمادة أو حالة طبية
- النمط مستمر ومستقر ومتفش عبر سياقات متعددة
- يسبب ضائقة سريرية ذات دلالة أو خللاً وظيفياً
- بدايته في مرحلة البلوغ المبكر

عندما يكون مجرد سمة شخصية

لا نُشخّص اضطراب الشخصية عندما:

- تظهر السمات البارانونية فقط في مواقف ضغط معينة
- يحتفظ الشخص بعلاقات صحية في معظم مجالات حياته
- يقبل الشخص التطمينات وتراجع شكوكه
- تغيب الضائقة أو الإعاقة الوظيفية الواضحة

⚠ التشخيص المبكر أو غير الدقيق قد يلحق ضرراً بالغاً بالمراجع. الدقة الإكلينيكية واجب مهني.

ما الذي يُسبب اضطراب الشخصية الزورانية؟

لا يوجد سبب وحيد — بل تفاعل معقد بين عوامل متعددة يُشكّل النمط الزوراني عبر الزمن.



العوامل العصبية

خلل في نظام الدوبامين يُفرط في "كشف التهديد". فرط نشاط اللوزة الدماغية، وضعف في القشرة الأمامية الجبهية مما يُقلل من المعالجة العقلانية للمعلومات.



العوامل البيئية

التعرض لتمييز عرقي أو ثقافي. الهجرة والعيش كأقلية. ظروف عمل أو معيشة تتسم بعدم الأمان المزمن.



العوامل الوراثية

ترتفع نسبة الاضطراب لدى ذوي مرضى الفصام. تشير دراسات التوائم إلى وراثية تتراوح بين 28-66%. جينات مرتبطة بمستقبلات الدوبامين والسيروتونين.



العوامل النفسية

صدمات الطفولة المبكرة وتجارب الإساءة والإهمال. أسلوب التعلق القلق/الرافض. نشأة في بيئة لا يمكن التنبؤ بها أو الوثوق بها.

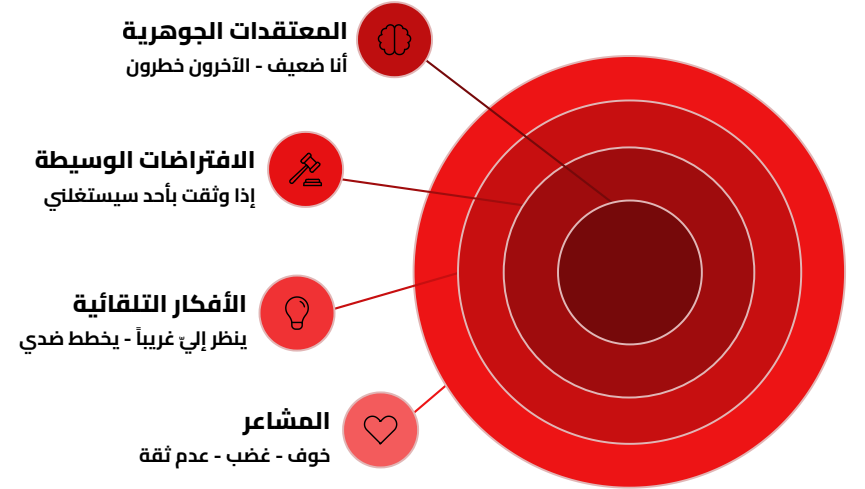
النموذج المعرفي لبيك (Beck) في الشخصية الزورانية

شرح المراحل

- المعتقدات الجوهرية: "أنا عرضة للأذى" و"الآخرون خطرون ولا يُؤتمنون" — تتشكل في الطفولة المبكرة.
- الافتراضات: قواعد صارمة تحكم السلوك مثل "يجب أن أكون يقظًا دائمًا".
- الأفكار التلقائية: تفسيرات فورية وسريعة تؤكد التهديد في كل موقف.
- الحلقة المغلقة: السلوكيات الدفاعية تُعزز انعزاله وتمنع أي تجربة تصحيحية.



فهم هذا النموذج ضروري لتصميم التدخل المعرفي الفعّال.



أبرز التشوهات المعرفية في الشخصية الزورانية

التهويل (Catastrophizing)

تضخيم التهديدات المتصورة
إلى أسوأ السيناريوهات. مثال:
"إذا علم بذلك سيدمر حياتي
بالكامل"

التحيز التأكيدي (Confirmation Bias)

الانتباه فقط للمعلومات التي
تؤكد شكوكه وتجاهل الباقي.
مثال: يتذكر كل موقف يُثبت
خيانة صديقه ويُهمل المواقف
الإيجابية.

التشخيص الذاتي (Personalization)

تفسير الأحداث المحايدة
باعتبارها موجهة شخصيًا. مثال:
"ضحك زملاء في الاجتماع —
كانوا يسخرون مني"

القفز إلى الاستنتاجات (Jumping to Conclusions)

الوصول إلى استنتاجات سلبية
بأدلة شحيحة. مثال: "تأخر ردّ
مديري على بريدي — إذن
يخطط لفصلي"

قراءة الأفكار (Mind Reading)

الاعتقاد بمعرفة نوايا الآخرين
السلبية دون دليل. مثال: "أعرف
أنه يكذب عليّ حتى لو بدا
صادقًا"

كيف يظهر المراجع الزوراني داخل الجلسة؟

تحديات العلاقة العلاجية

مقاومة الانفتاح

يُشارك معلومات جزئية خشية الاستغلال.

اختبار الحدود

يتحقق من استجابة المعالج للأسئلة الاستفزازية.

التحويل السلبي

قد يُسقط على المعالج دور الشخص المؤذي.

السمات السلوكية الملاحظة

- يفحص الغرفة عند الدخول بحثًا عن تهديدات
- يتساءل عن سبب الأسئلة ("لماذا تسألني هذا؟")
- يُبدي مقاومة لتدوين الملاحظات
- يختبر المعالج باختبارات خفية للثقة
- يُفسّر أي صمت كدليل على الرفض

نماذج من الحوار الحقيقي

المراجع: "هل ستُخبر أحدًا بما أقوله هنا؟"
المعالج الفعّال: "أفهم قلقك — السرية حق لك. دعني أشرح لك بالتفصيل حدودها"

المراجع: "لماذا تسجّل ملاحظات؟ ماذا تكتب؟"

المعالج الفعّال: "هل تودّ أن تطلع على ما أكتبه؟ لا مشكلة في ذلك"



التشخيص التفريقي

التمييز الدقيق بين هذه الحالات يحدد مسار العلاج بأكمله — أخطاء التشخيص التفريقي من أكثر الأخطاء الإكلينيكية شيوعًا.

الاضطراب	أوجه التشابه	الفوارق الجوهرية	مفتاح التمييز
الاضطراب الوهامي	شك مستمر وتفسير سلبي للواقع	أوهام ثابتة ومتسقة، لا تأثير على الأداء العام	وجود وهم بارز ومتبلور بوضوح
الفصام	أفكار بارانوية وعدم ثقة	هلاوس، أفكار مشتتة، خلل وظيفي حاد	غياب الهلاوس في PPD
اضطراب الشخصية الفصامية النمط	الانسحاب والشك	تفكير سحري، إدراك شاذ، خطاب غريب	التفكير الغريب والإدراك الشاذ
اضطراب الشخصية الحدية	مخاوف من الخيانة، حساسية للرفض	عدم استقرار انفعالي، إيذاء ذاتي، خوف من الهجر	التقلب الانفعالي الشديد
اضطراب ما بعد الصدمة	يقظة مفرطة، عدم ثقة	مرتبط بصدمة محددة، ذكريات طفيلية، استجابات فزعية	وجود صدمة واضحة وأعراض إعادة المعاشاة

التقييم الإكلينيكي: الأسئلة والعلامات والأخطاء

أهم الأسئلة الإكلينيكية

1. "هل تشعر أن الناس يراقبونك أو يتحدثون عنك؟"
2. "هل سبق أن شعرت أن أحدًا يحاول الإضرار بك؟"
3. "كيف تتعامل مع من يُخَيِّب ظنك؟"
4. "هل تجد صعوبة في الوثوق بالناس المقربين؟"
5. "ما الذي يجعلك تُشارك معلومات مع شخص ما؟"

العلامات السريرية الموجّهة

- فحص الغرفة عند الدخول
- أسئلة استفسارية متكررة عن السرية
- تاريخ من العلاقات الفاشلة ومشكلات العمل
- دعاوى قضائية متكررة

الأخطاء الشائعة في التقييم

→ الخلط مع الواقعية →

تصديق الرواية الزورانية دون
تقييم الأدلة بموضوعية.

→ التشخيص المتسرع

تشخيص الاضطراب بعد جلسة
واحدة دون استيفاء المعايير.

→ إهمال السياق الثقافي →

الشك قد يكون استجابة
تكيفية لظروف بيئية
حقيقية.

→ إهمال المصادر
الجانبية

الاعتماد الكلي على رواية
المراجع دون تقييم شامل.

بناء التحالف العلاجي: أساس العلاج الناجح

التحالف العلاجي مع المراجع الزوراني هو أصعب مراحل العلاج وأكثرها حساسية — وبناءً عليه بشكل صحيح يحدد نجاح أي تدخل لاحق.

❌ أخطاء تدمر العلاقة

- المبالغة في الدفء المبكر — يبدو مريبًا له
- تفسير شكوكه بشكل مباشر في البداية
- الدفاع عن الأشخاص الذين يشك فيهم
- تقديم التطمينات دون دليل
- التحدث بطريقة تبدو "أكثر من اللازم"

✓ كيف نبني الثقة

- الشفافية الكاملة حول السرية وحدودها
- الاتساق والموثوقية في كل جلسة
- احترام حاجته للسيطرة والحدود
- تجنب المفاجآت — إعلامه بأي تغيير مسبقًا
- التحقق الدائم من فهمه لما يجري



العلاج المعرفي السلوكي (CBT) للشخصية الزورانية



الحوار السقراطي

قيادة — *Socratic Questioning*
المراجع للشك في افتراضاته بأسئلته.
مثال: "إذا كان صديقك يخطط ضدك،
"لماذا يتصل بك يوميًا للاطمئنان؟"



التجارب السلوكية

اختبار — *Behavioral Experiments*
التنبؤات السلبية في الواقع. مثال:
"جرب أن تشارك معلومة بسيطة مع
"زميل وانظر ماذا يحدث"



اختبار الواقع

التحقق الفعلي — *Reality Testing*
من دقة التفسيرات. مثال: "هل سألت
زميلك مباشرة ما قصده بتلك
"العبارة؟"



إعادة البناء المعرفي

تحدي — *Cognitive Restructuring*
المعتقدات الجوهرية بجمع أدلة
مضادة. مثال: "ما الدليل على أن
مديرك يريد فصلك؟ وما الأدلة
"المضادة؟"

علاجات متقدمة للشخصية الزورانية

علاج المنطقية الذهنية (MBT)

يُعلّم المراجع التمييز بين الحقائق الموضوعية والتفسيرات الذاتية — مهارة محورية في الشخصية الزورانية.

الخطوة 1: الوقفة

"ما الذي حدث فعلاً؟" — وصف الحدث دون تفسير.

الخطوة 2: التفسيرات

"ما التفسيرات الممكنة لهذا الحدث؟" — توليد بدائل متعددة.

الخطوة 3: التحقق

"ما الأدلة التي ترجّح كل تفسير؟"

❑ فعّال بشكل خاص مع المرضى الذين يصعب معهم التعامل MBT المباشر مع المعتقدات.

علاج المخططات (Schema Therapy)

يستهدف المخططات الجوهرية التي تشكّلت في الطفولة:

- مخطط الإساءة/عدم الثقة: العمل على إعادة معالجة التجارب الأولى
- الحرمان العاطفي: تلبية الاحتياجات العاطفية الأساسية
- حوار بين الجانب الخائف والجانب البالغ: Chair Work
- إعادة كتابة الذكريات المؤلمة بطريقة تعافية: Imagery Rescripting
- تقديم تجربة علاقة آمنة ومتسقة: Limited Reparenting

علاج القبول والالتزام (ACT)

- التفريق بين الفكرة وحقيقة الواقع: Defusion
- قبول الشك دون الانجراف خلفه: Acceptance
- التركيز على ما يمنح الحياة معنى رغم القلق: Values

العلاج الدوائي: متى يُستخدم وماذا تقول الأدلة؟

لا يوجد دواء مُعتمد رسميًا لعلاج اضطراب الشخصية الزورانية، غير أن الأدوية تُستخدم بشكل تعاوني في حالات بعينها.

متى يُستخدم الدواء؟	الخيارات الدوائية	تحذيرات وملاحظات
• عند وجود قلق حاد أو توتر يعيق العلاج النفسي • حالات مع أعراض ذهانية عابرة • الاكتئاب المصاحب للاضطراب • حالات الانتكاس الحادة	• مضادات الذهان المنخفضة الجرعة: للأعراض البارانونية الحادة • مضادات الاكتئاب (SSRIs): للقلق والاكتئاب المصاحب • المثبتات المزاجية: في حالات اضطراب ثنائي القطب المتزامن	• الدواء وحده غير كافٍ — مساند للعلاج النفسي فقط • مقاومة الدواء شائعة بسبب الشك في نوايا الطبيب • الالتزام الدوائي تحدٍّ علاجي كبير في هذه الفئة • تجنب وصف الدواء دون بناء علاقة علاجية كافية

أحدث الدراسات والمراجعات المنهجية (حتى 2025)

ملخص أبرز ما توصلت إليه الأبحاث المحدثّة الحديثة في مجال اضطراب الشخصية الزورانية:

1

Kelber et al. (2023) — JCPP

مراجعة منهجية أثبتت أن التدخلات المعرفية السلوكية المتخصصة تحسّن الأعراض البارانونية بشكل ذي دلالة إحصائية مقارنةً بالعلاج المعتاد.

2

Freeman et al. (2024) — Lancet Psychiatry

أثبتت دراسة AVATAR-2 فاعلية العلاج المعرفي الرقمي المعزز في تقليل الأفكار البارانونية المستمرة بنسبة 37% مقارنةً بالضبط.

3

Meehan et al. (2024) — Personality Disorders

دراسة طويلة تؤكد أن علاج المخططات (Schema Therapy) يحقق تحسّنًا معتدلاً في الشخصية الزورانية، مع تأكيد أهمية جودة التحالف العلاجي كمنبئ أساسي.

4

Bunn et al. (2025) — Psychological Medicine

مراجعة منهجية وميتا-تحليل تُظهر أن العوامل الوراثية تفسّر ما بين 28-66% من تباين السمات البارانونية، مع تأكيد التفاعل الجين-بيئي.

حالة سريرية: نشاط تدريبي تطبيقي

سارة، 42 عامًا، معلمة. تراجع أداؤها المهني بشكل ملحوظ. تعتقد أن زميلاتها يتحدثن عنها في غرفة المعلمين وأن المديرية تجمع "ملفات" عليها. طُلقت مرتين. لا صديقات مقربات. في الجلسة الأولى، سألت المعالج: "من الذي أرسلك؟" رفضت الجلوس ظهرها للباب. تقول إن طبيبها الأخير أعطى تقاريرها لجهة حكومية. تاريخ: نشأة في بيئة متقلبة، أب غير متنبأ به، لا تاريخ ذهاني.

الخطة العلاجية

كيف ستبني التحالف؟ ما النهج العلاجي الأنسب؟ هل ثمة دور للدواء؟

الصياغة المعرفية

ما المعتقدات الجوهرية والافتراضات والتشوهات المعرفية البارزة في الحالة؟

التشخيص التفريقي

ما الاضطرابات التي يجب استبعادها؟ وما الفوارق المميّزة في هذه الحالة؟

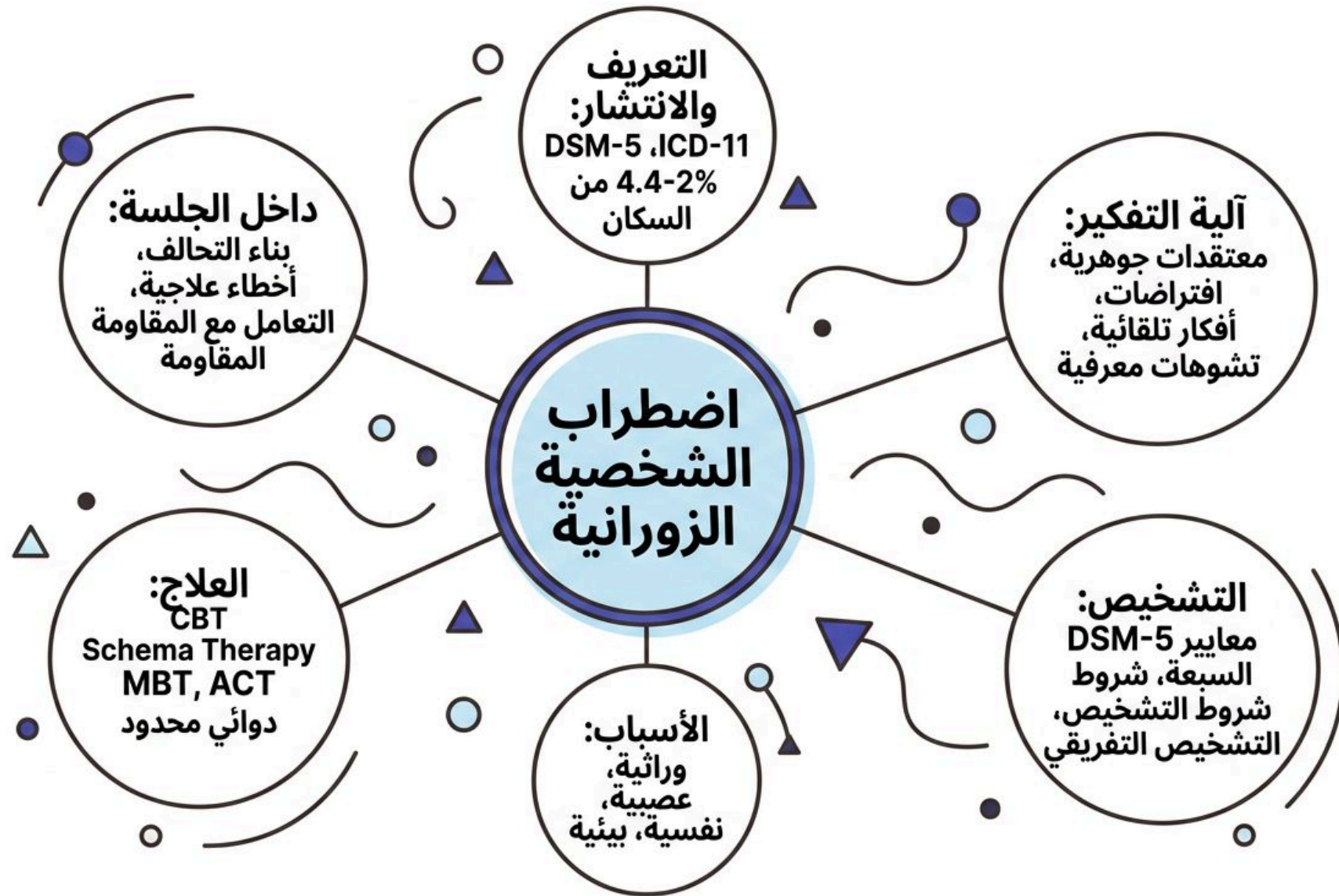
التشخيص

ما هو تشخيصك المحتمل وفق DSM-5؟ وما مستوى الشدة وفق ICD-11؟

أهم الأخطاء العلاجية الشائعة

الخطأ العلاجي	لماذا يحدث؟	كيف تتجنبه؟
مواجهة المعتقدات الزورانية مبكرًا	رغبة المعالج في "إصلاح" التفكير بسرعة	بناء التحالف أولًا، ثم التحدي التدريجي بعد الثقة
الدفاع عن الأشخاص المشكوك فيهم	شعور المعالج بالواجب لتصحيح الصورة	الاستكشاف المحايد بدلًا من الدفاع: "ما الذي جعلك ترى ذلك؟"
التطمين المفرط وغير المُعلَّل	رغبة المعالج في تهدئة المراجع	التطمين المبني على الأدلة فقط، لا الطمأنينة الفارغة
تصديق الرواية الزورانية كاملًا	الخوف من تحدي المراجع أو إيذاء علاقته	الإشراف الإكلينيكي المنتظم والإشراف الخارجي
الاستعجال في تحديد أهداف طموحة	تقليل صعوبة الحالة أو ضغط إكلينيكي	أهداف صغيرة وقابلة للقياس — التركيز على الوظائف اليومية
إهمال الإشراف والتأمل الذاتي	خطأ المعالج في قراءة المشاعر المضادة	الإشراف الإكلينيكي المنتظم، تدوين ردود الفعل المضادة

خريطة ذهنية: ملخص شامل للدورة



يُمثل هذا المخطط الشبكة المتكاملة لمحاور الدورة — من التعريف والتشخيص، إلى الفهم النظري، وصولًا إلى التدخل العلاجي الفعّال.

المراجع العلمية

وفق نظام التوثيق APA 7th Edition

الدراسات والمراجعات الحديثة

Freeman, D., et al. (2024). AVATAR therapy for paranoia: Randomised controlled trial. *Lancet Psychiatry*, 11(3), 211–223.

Kelber, M. S., et al. (2023). Cognitive-behavioural interventions for paranoia: Systematic review. *Journal of Clinical Psychology*, 79(4), 820–838.

Meehan, K. B., et al. (2024). Schema therapy for personality disorders: Long-term outcomes. *Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment*, 15(1), 45–62.

Bunn, G., et al. (2025). Heritability of paranoid traits: Meta-analysis. *Psychological Medicine*, 55(2), 301–315.

المراجع المعرفية والعلاجية

Beck, A. T., Davis, D. D., & Freeman, A. (2015). *Cognitive therapy of personality disorders* (3rd ed.). Guilford Press.

Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). *Schema therapy: A practitioner's guide*. Guilford Press.

التصنيفات التشخيصية الرئيسية

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.). APA Publishing.

World Health Organization. (2019). *International classification of diseases* (11th rev.). WHO Press.



جميع المراجع مُوثَّقة وفق أحدث إصدار من APA (السابع). يُنصح بمراجعة قواعد بيانات PsycINFO و PubMed للاطلاع على أحدث الأبحاث المنشورة.